UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Pneumologie
Découverte d'anomalies à l'auscultation pulmonaire
Avec patient
Avec geste clinique

Nom du rédacteur : Axel Dubruque **Date de rédaction :** 23/01/2024

Situation de départ N° 20 – Découverte d'anomalies à l'auscultation pulmonaire

Domaine de compétence n°1 : Examen clinique

Domaine de compétence n°2 : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1- Chercher les éléments de l'interrogatoire et les signes cliniques pulmonaires et extrapulmonaires pour orienter l'enquête étiologique

2- Argumenter et justifier les explorations fonctionnelles adaptées

Patient simulé nécessaire à la station : OUI

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Stéthoscope

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autre que ce qui est précisé.

Synopsis : Vous avez 80 ans et vous êtes ancienne caissière maintenant retraité. Ce matin, en regardant la télévision, vous avez présenté une détresse respiratoire aiguë.
Un étudiant en médecine va vous interroger et vous examiner.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Poitier Prénom : Thérèse Âge : 80 ans Caissière retraité Veuve Domicile
Antécédents	Hypertension artérielle Toxique : Pas de tabac ni d'alcool
Médicaments actuels/ Toxiques	*Ramipril*
Etats d'esprit/ comportement	Posture : Semi assise Douleur : Faible Angoisse : Moyenne Colère : Faible
Déroulement du scénario	Vous êtes allongée/assise/ etc. Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *Ex : **« Ce matin alors que je regardais la télé je me suis mise à manquer d'air et à respirer de plus en plus vite, j'ai appelé le SAMU qui m'a amené aux urgences »*** Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement. Il doit normalement vous examiner. Laissez-vous guider.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par L'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Avez-vous du mal à respirer	Oui
Est la première fois que vous avez du mal à respirer	Oui c'est la première fois
Avez-vous eu des douleurs à la poitrine	Non
Est-ce que vous toussez	Oui j'ai une toux grasse depuis ce matin
Est-ce que vous crachez	Oui je crache, j'ai l'impression d'être encombré
De quelle couleur sont vos crachats	Ils sont jaunes et vert
Avez-vous de la fièvre ?	Je n'ai pas pu la prendre pas mais j'ai chaud oui
Avez-vous craché du sang	Non

Instructions à l'étudiant

Vous êtes médecin de garde aux urgences quand vous recevez via les pompiers une femme de 80 ans, sans antécédent. Madame Poitier qui a appelé le 15 pour des difficultés à respirer apparue de manière brutale. Devant une saturation à 90 % elle est mise sous oxygène aux lunettes.

Votre externe a réalisé une première auscultation et vient vous voir en vous demandant de l'aider car il a l'impression d'entendre un foyer de crépitants en base droite.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Chercher les éléments de l'interrogatoire ciblé et les signes cliniques pulmonaires et extrapulmonaires pour orienter l'enquête étiologique
2. Décrire l'examen complémentaire qui vous est apporté et conclure

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
Recherche la présence d'expectoration purulente	
Recherche de signes de lutte/faillite (tirage abdominal, balancement thoraco-abdominal)	
Recherche d'une fièvre à l'examen physique (Dire qu'il y a une fièvre à 38,3 °C)	
Recherche une diminution de murmure vésiculaire (Diminution du murmure vésiculaire en basal droit)	
Recherche un bruit surajouté (crépitant, sibilant, ronchus…) (Indiquez la présence de râles crépitants en basal droit)	
Recherche une augmentation des vibrations vocales en faisant prononcer « 33 » au patient (Dire qu'il y a une augmentation des vibrations vocales à droite)	
Recherche à la percussion une matité (Dire qu'il y a une matité basal droite)	
Tâche 2 **Lui donner la radio thoracique après la fin de son examen physique**	
Savoir dire que la radiographie présente les critères de bonne qualité : bien centrée, réalisée debout (poche à air gastrique), visualisation de 6 arcs costaux antérieurs, clavicules symétriques.	
Parle d'un syndrome alvéolaire : • Opacité • Systématisé • Lobe inférieur droit • Avec bronchogramme aérique	
Absence de syndrome interstitiel	
Pas d'épanchement pleural avec des culs sacs pleuraux libres	
Conclue en une pneumonie franche lobaire aiguë du lobe inférieur droit (OK si dit tout)	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Communication non verbale	
Aptitude à structurer/mener l'entrevue	
Aptitude à faire la synthèses des donnés	

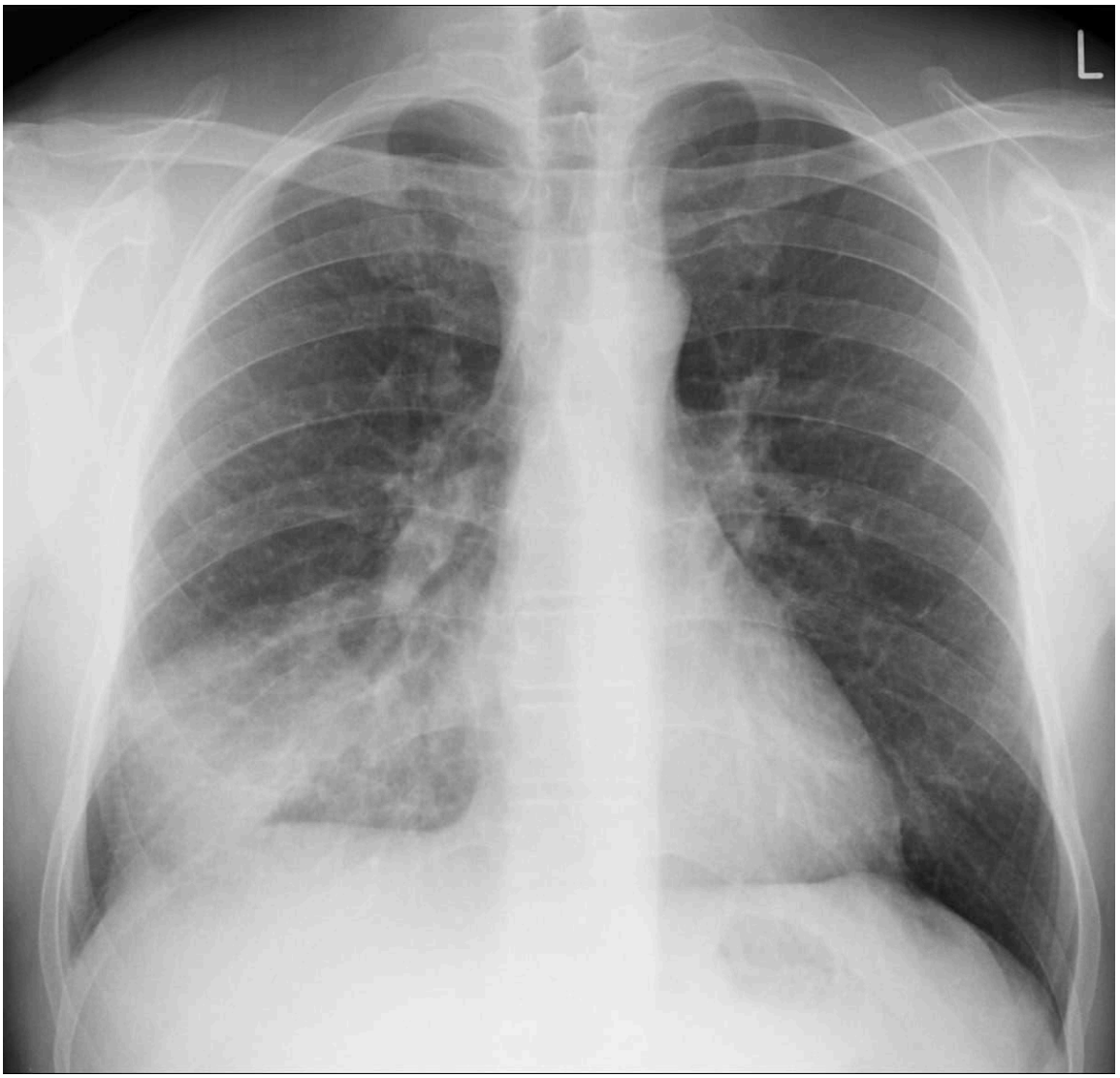
Préciser quand l'examinateur doit intervenir pour donner un signe clinique positif

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tâche 1	
Recherche la présence d'expectoration purulente	1
Recherche de signe de luttes/faillites (tirage abdominal, balancement thoraco-abdominal)	1
Recherche d'une fièvre à l'examen physique	1
Recherche une diminution de murmure vésiculaire	1
Recherche un bruit surajouté (crépitant, sibilant, ronchi…)	1
Recherche une augmentation des vibrations vocales en faisant prononcer « 33 » au patient	1
Recherche à la percussion une matité	1
Tâche 2	
Savoir dire que la radiographie présente les critères de bonne qualité : bien centrée, réalisée debout (poche à air gastrique), visualisation de 6 arcs costaux antérieurs, clavicules symétriques.	1
Parle d'un syndrome alvéolaire : ● Opacité ● Systématisé ● Lobe inférieur droit ● Avec bronchogramme aérique *1 point pour chaque terme*	1 à 4
Absence de syndrome interstitiel	1
Pas d'épanchement pleuraux avec des culs sacs pleuraux libres	1
Conclue en une pneumonie franche lobaire aiguë du lobe inférieur droit (OK si dit tout)	1
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Communication non verbale Performance insuffisante 0 point: Se comporte de manière inappropriée (ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements Performance limite 0,25 point: Tente d'établir un contact visuel Présente les difficultés à établir la conversation (priorise l'accomplissement de la tâche clinique), pouvant induire la frustration du patient/pair Performance satisfaisante 0,5 point: Regarde le patient ou le pair la majeure partie du temps Etablit la conversation Performance très satisfaisante 0,75 point: Regarde le patient ou le pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient ou du pair et réagit de manière appropriée par son comportement et ses gestes Performance remarquable 1 point: Montre une bonne maitrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation et/ou d'établir une relation	1
Aptitude à structurer/mener l'entrevue	1

Marquis

Performance insuffisante 0 point	Performance limite 0,25 point	Performance satisfaisante 0,5 point	Performance très satisfaisante 0,75 point	Performance remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème ; couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème Ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée et logique

Aptitude à faire la synthèses des donnés — 1

Performance insuffisante 0 point	Performance limite 0,25 point	Performance satisfaisante 0,5 point	Performance très satisfaisante 0,75 point	Performance remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur